

SCANNER & IRM ÎLE-DE-FRANCE

Centre d'Imagerie Médicale
14 boulevard Saint-Michel
75005 PARIS
Résultats : imagerie-idf.fr
Téléphone : 01.43.00.00.00

Nom : BENSAID
Prénom : Karim
Date de naissance : 27/05/1978
Sexe : M

Paris, le 20/04/2026
Dr Élodie MOREAU
Médecin radiologue

SCANNER ABDOMINO-PELVIE

Indication :

Douleur lombaire aiguë droite irradiant vers l'aîne, d'apparition brutale, associée à des nausées.
Suspicion de colique néphrétique.

Technique :

Acquisition tomodensitométrique abdomino-pelvienne sans injection de produit de contraste (uro-scanner low dose).
Reconstructions multiplanaires dans les plans axial, sagittal et coronal.
Analyse en fenêtres urinaires et parenchymateuses.

Résultats :

Reins et voies urinaires :

Présence d'un calcul hyperdense de l'uretère lombaire droit mesurant environ 6 mm de grand axe, situé à environ 3 cm de la jonction pyélo-urétérale.

En amont, dilatation modérée des cavités pyélocalicielles droites (hydronéphrose) associée à une discrète dilatation de l'uretère proximal.

Présence d'un infiltrat de la graisse péri-rénale droite, traduisant une souffrance obstructive récente.

Rein gauche de taille et morphologie normales, sans dilatation ni lithiase visible.

Vessie :

Vessie correctement remplie, sans anomalie pariétale visible.
Pas de calcul intravésical.

Parenchymes abdominaux :

Foie de taille et densité normales.

Pas de lésion focale suspecte.

Vésicule biliaire sans anomalie.

Pancréas, rate et surrénales sans particularité.

Tube digestif :

Pas d'épaississement pariétal digestif suspect.

Appendice visualisé, d'aspect normal.

Aires ganglionnaires :

Pas d'adénopathie abdomino-pelvienne significative.

Cavité péritonéale :

Pas d'épanchement péritonéal.

Structures osseuses :

Pas d'anomalie osseuse suspecte.

Conclusion :

Calcul urétéral lombaire droit de 6 mm responsable d'une **uropathie obstructive modérée en amont** (hydronéphrose droite).

Aspect compatible avec une **colique néphrétique obstructive droite récente**.

Absence de complication associée identifiable (pas de rupture des cavités, pas de signe d'infection visible au scanner).

Recommandations :

Prise en charge urologique adaptée avec traitement antalgique.

Surveillance de l'élimination spontanée du calcul.

Discussion d'un traitement interventionnel (lithotritie ou urétéroscopie) en cas de non progression ou de complications.